# Säker och Användarcentrerad Vård och Omsorg i Hemmiljö

Medarbetarens perspektiv på hinder och möjligheter för utveckling och ökad samordning



KTH VETENSKAP OCH KONST · VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet · Stockholms stad · cuviva · Capio · Region Stockholm

Läs rapporten digitalt: 

Författare: Magnus Eneberg, Senior forskare på KTH
Datum: 2023-04-27
ISBN: 978-91-8040-539-3
TRITA–ITM–RP 2023:3
Omslagsfoto: Micheile Henderson på Unsplash

# Innehållsförteckning


Förord 5

Projektbeskrivning 6
Bakgrund 6
Projektorganisation 8
Metoder/aktiviteter 8

Lärdomar och insikter 11
Vård- och omsorgssystemet 11
Perspektiv och målkonflikter 12
Drivkrafter och behov 14
Styrning och granskning 16
Samverkan och ansvar 18
Utveckling och upphandling 20

Slutsatser och utvecklingsområden 22
Stödsystem för kommunikation 23
Samordnad individuell plan 24
Samverkan kring äldres hälsa 25

Framtidsvision 28
Positiv och negativ brainstorming 29
Försämrade förutsättningar 31
Förbättrade förutsättningar 31
Förbättrade och nya tjänsteerbjudanden 32

Nästa steg 36

Slutord 37

Referenser 38

Projektledning:




Finansiering:




I samverkan med:












# Förord

Denna rapport vänder sig till alla er som vill ta del av medarbetarens perspektiv, erfarenheter, utmaningar och behov när de utför vård- och omsorgs-tjänster i hemmet hos sköra äldre.



Foto: Unseen Studio, Unsplash

I rapporten presenterar vi resultaten från projektet Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö med deltagare från KTH, Region Stockholm, Stockholms stad, Capio Primärvård AB och Cuviva AB. Med projektet vill vi bidra till ökad samordning i vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre som erhåller vård och omsorg i sin hemmiljö.

Studien visar på ett antal hinder som gör det utmanande att implementera nya arbetsmetoder och lösningar. Bland annat har vi identifierat målkonflikter mellan såväl organisationer som mellan professioner och deras respektive drivkrafter, ansvar och befogenhet.

Studien visar även på ett behov av översyn kring styrmetoder såsom ersättningsmodeller, uppföljning, granskning och hur lagar tolkas. Baserat på insikterna från projektet har vi identifierat ett antal områden för utveckling som skulle vara värdefulla att utforska i kommande projekt.

Utvecklingsområdena användes som inspiration vid en avlutande workshop med deltagare från hemsjukvård, hemtjänst, rehab, biståndshandläggare och strateger från de olika verksamheterna. Workshopen bestod av ett antal kreativa övningar där deltagarna fick utveckla idéer kring en visionsdriven och samordnad vård och omsorg. Övningarna var utforskande och syftet med dem var bland annat att urskilja de hinder och möjligheter som påverkar förflyttningen mot en önskad situation.

Ni är nu välkomna att följa med på en utforskande resa i medarbetarens vardag!

/Magnus Eneberg, Senior forskare, KTH

# Projektbeskrivning

## Bakgrund

Vård- och omsorgssystemet står inför många utmaningar, inklusive en ökad andel äldre som väntas få vård och omsorg i hemmiljö, krav på ökad kostnadseffektivitet och möjligheter skapade av ny digital teknik. En effektiv vård och omsorg förutsätter ökad samverkan mellan de olika aktörerna i vård- och omsorgssystemet och en ökad samordning kring de aktiviteter som utförs (SOU 2022:41). Ett holistiskt perspektiv är avgörande för att säkerställa en samordnad vård och omsorg som sträcker sig över organisatoriska gränser. Det krävs även nya förutsättningar och lösningar som understödjer interorganisatorisk kommunikation och samordning. Informationsutbyte om patienter och ökad vårdsamordning kan hindras av oklara roller, ansvar och processer. Dessa hinder måste undanröjas för att undvika ineffektiva eller kontraproduktiva insatser i stället för högkvalitativ, patientsäker och kostnadseffektiv vård och omsorg i hemmiljö.

Projektets syfte har varit att främja en ökad samordning inom vårdnätverket för de sköra äldre som vårdas i hemmiljö. I projektet har vi utgått från medarbetarens perspektiv, erfarenheter och behov när de levererar sina tjänster till patient/brukare. Medarbetarnas aktiva deltagande har varit avgörande för att resultaten skall kunna skapa en sund arbetsmiljö och framgångsrika organisatoriska initiativ.

Målet med projektet är att resultaten ska stödja framtida utveckling av nya arbetsrutiner, digitala eller organisatoriska lösningar, upphandlingsprocesser och nya värdeskapande tjänster.
En annan målsättning har varit att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte och lärande över organisatoriska gränser.

Utvecklings- och forskningsprojektet startade i oktober 2019 med finansiering från Vinnova, som en del av utlysningen ”Innovationsledning och Organisering – Forskning för ökad innovationsförmåga”. Projektet var tänkt att löpa under tre år men fick pausas och förlängas på grund av Coronapandemin.

En kartläggning med fokus på:
- medarbetares, upplevelser och behov i utförandet av vård- och omsorgstjänster i hemmiljö,
- processer, rutiner och verksamhetskrav,
- upplevda hinder för innovation.

Utvecklingsområden hittar du på sidan 22



Foto: John Moeses Bauan, Unsplash

## Projektorganisation

Deltagare i projektet inkluderar forskare från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, representanter från Stockholms Stad, Region Stockholm, Cuviva AB och Capio Primärvård AB. Från Stockholms stad deltog en strateg från Äldreförvaltningen, äldreomsorgschef, biståndshandläggare från Farsta stadsdelsförvaltning, samt chef, koordinator och medarbetare från Farsta Norra Hemtjänst. Representanter från Region Stockholm inkluderar handläggare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt FoU-strateg från avdelningen för Forskning och innovation. Cuviva AB medverkar med sin COO och från Capio Primärvård AB verksamhetschefen samt chef och medarbetare från hemsjukvården vid Gubbängens vårdcentral och fysioterapeut från Capio Rehab Farsta.




## Metoder/aktiviteter

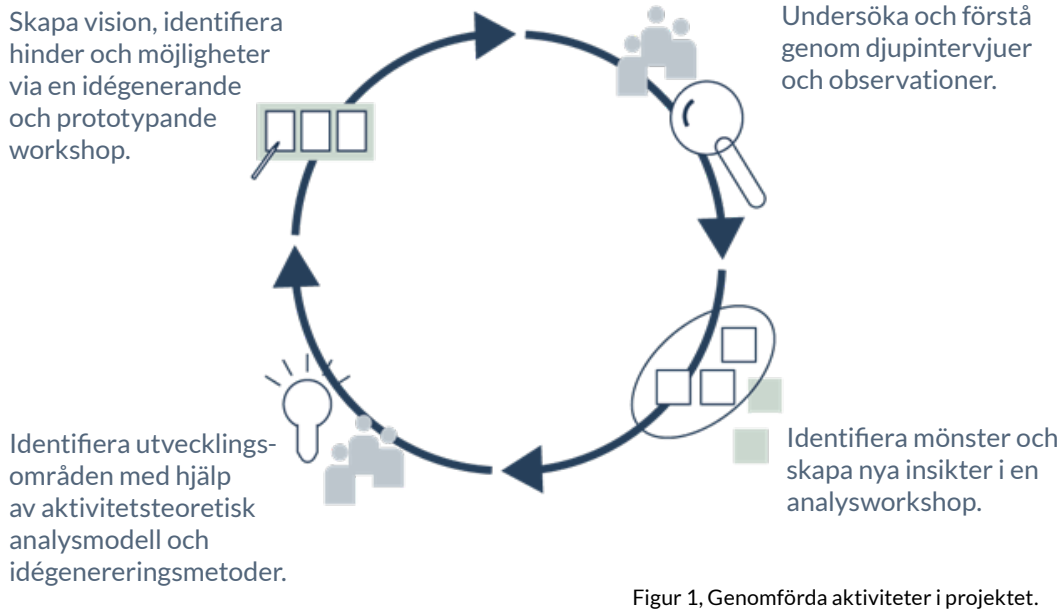
Det krävs nya tillvägagångssätt och metoder för att förstå förändringar i komplexa socio-tekniska system (Irwin, 2015) såsom hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemet. Det räcker inte att bara kartlägga systemet och dess aktörer, utan en djupare förståelse för mönster, relationer och kontinuerliga förändringar behövs. Dessutom måste man ta hänsyn till kulturella aspekter, såsom arbetskultur, normer, institutionella strukturer och policyer. Designers har börjat tillämpa metoder och verktyg från systems thinking (system- tänkande) och integrera designmetoder och processer med systemtänkande för att hantera komplexa samhällsutmaningar (Rylander et al. 2021; Costa et al., 2019; Jones, 2014).

I projektet har främst kvalitativa tjänstedesign-metoder använts. Målsättningen har varit att fånga med-arbetares erfarenheter, utmaningar och behov. Metoderna som används är i de flesta fall användarcentrerade och oftast skapas nya insikter och lösningar genom samskapande. Genom att olika aktörer möts så kan flera, ofta konkurrerande, perspektiv mötas. Utgångs-punkten är användarens upplevelser och behov. Samtidigt skapas upplevelser i interaktion med andra aktörer vilket kan vara andra människor men även interaktion som sker via artefakter som exempelvis digitala lösningar. Ett holistiskt förhållningssätt är därför en förutsättning i tjänstedesignprocessen vilket sker i en kontinuerlig iteration mellan en djupare förståelse av individen och en förståelse för de relationer och interaktion som sker i systemet som helhet.

Forskargruppen genomförde tidigt i projektet djupintervjuer med aktörer på olika nivåer i deltagande organisationer.

Medarbetare har haft en framträdande roll i projektet genom användandet av samskapande metoder vilket illustreras i figur 1. Arbetsgruppen deltog i utbildningar i användar-centrerade tjänstedesignmetoder för attsedan genomföra observationer och intervjue i varandras organisationer. En gemensam analysworkshop arrangerades där data från intervjuer och observationer tematiserades vilket resulterade i nya insikter.

Deltagande forskare analyserade det empiriska materialet med hjälp av en aktivitetsteoretisk modell (Engeström, 1999). Syftet var att upptäcka samband, spänningar och målkonflikter i vård- och omsorgssystemet, såsom mellan aktörer, olika målsättningar, tolkning av lagar och riktlinjer. Utifrån de insikter som skapats identifierades mönster och utvecklingsområden att ta vidare i en workshop med en större grupp medarbetare än de som varit en del av arbetsgruppen. Målsättningen med denna övning var att samskapa visioner kring ett tänkt framtida läge och identifiera barriärer och möjliggörare i systemet. Resultaten från projektet är tänkt att stödja en framtida utveckling av organisatoriska lösningar, nya arbetssätt och utveckling av digitala kommunikationslösningar.




Figur 1, Genomförda aktiviteter i projektet.

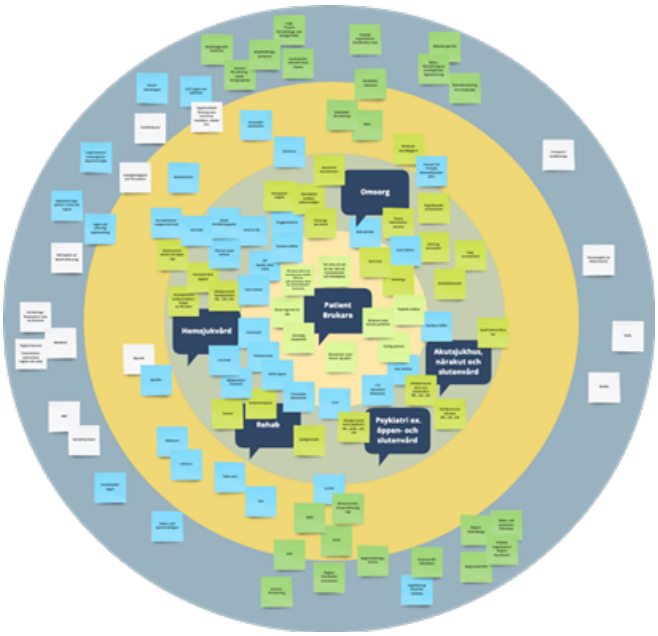


Foto: Amy Hirschi, Unsplash

# Lärdomar och insikter

## Vård- och omsorgssystemet

Tidigt i projektet genomfördes en kartläggning och analys av olika aktörer som på något sätt påverkar den vård och omsorg som erbjuds sköra äldre som vårdas i hemmiljö.  Med aktörer avses i det här fallet inte bara individer eller grupper av människor, utan även de verktyg och redskap som används i interaktionen mellan individerna. Figur 2 är inte menad att läsas rakt av utan visar den analysmodell som användes för att identifiera aktörers inbördes relationer. I den centrala cirkeln finns brukare/ patienter och deras anhöriga. Ju längre ut från centrum desto längre bort från direkt utförande av vård- och omsorgstjänster befinner sig aktören. I Tabell 1 (på sidan 13) beskrivs de grupper av individer och organisationer som nämndes i studien samt deras drivkrafter och målsättning.



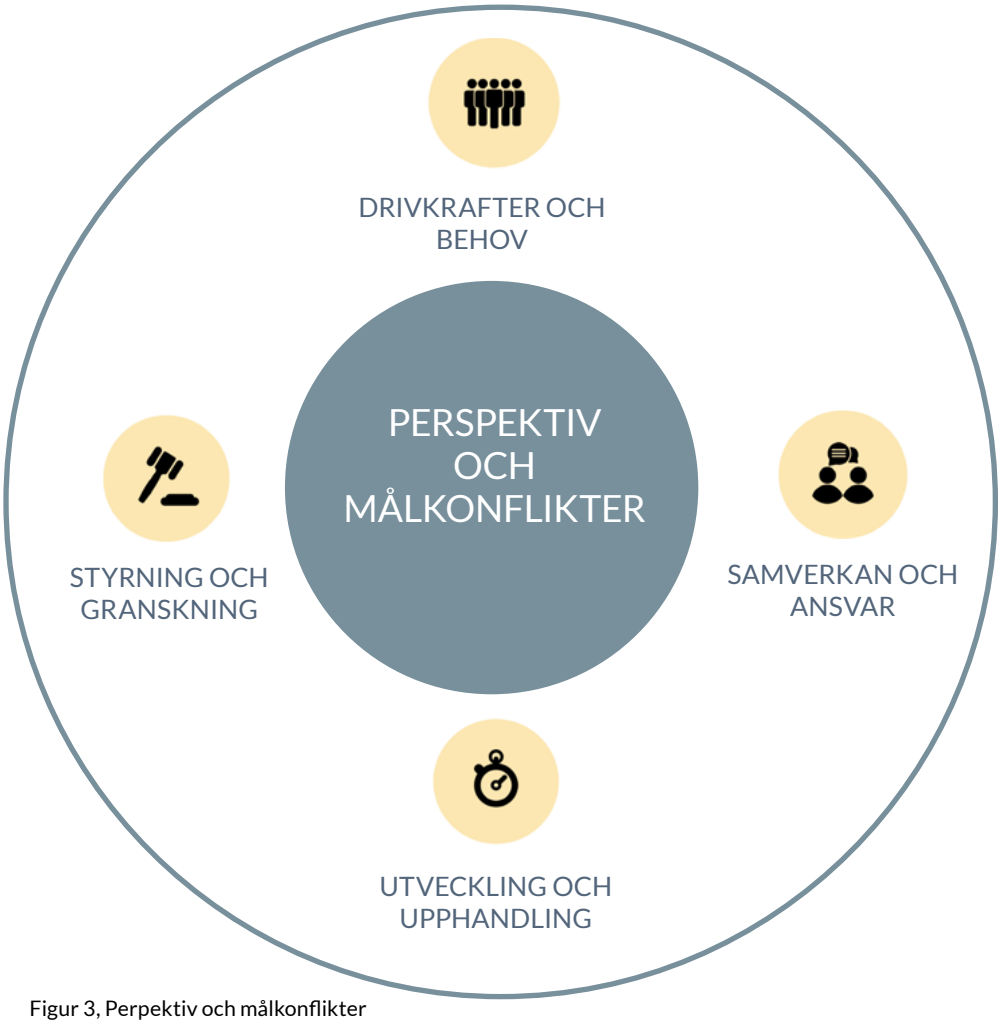

Figur 2, Systemcirkel

# Perspektiv och målkonflikter

Studien som genomfördes genererade insikter kring ett antal teman som återger olika upplevda problem, behov, perspektiv och målkonflikter (se figur 3). Genom att identifiera och analysera dessa teman kan man få en bättre förståelse för situationen och möjliga utvecklingsområden. Det är viktigt att notera att varje tema kan vara relaterat till flera andra teman och att det är en komplex väv av interaktioner som påverkar helheten.

”Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag som säger att vi ska tillgodose skälig levnadsnivå så måste man fylla ut vad skälig levnadsnivå är i vår kommun och då kan det handla om hur ofta tycker vi att personer ska ha rätt att komma ut på promenad? Hur ofta ska man få städat?”

Biståndshandläggare




Figur 3, Perpektiv och målkonflikter

| Aktörer | Beskrivning av aktörer | Drivkrafter och målsättning med aktiviteter |
|---|---|---|
| Patient/ Brukare | Heterogen grupp med olika behov och sjukdomsbild, bakgrund, förmågor och förutsättningar att påverka den egna vård- och omsorgen. | Att leva ett så självständigt, socialt, friskt och tryggt liv som möjligt. |
| Närstående/ God man | Heterogen grupp som kan vara en anhörig, vän granne, godman. Olika förutsättningar och förmågor att påverka vård och omsorg av närstående. | Att stödja och skydda närstående. |
| Medarbetare | Undersköterska, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biståndshandläggare, omsorgspersonal, assistent/ koordinator. | Drivkrafter tenderar att vara stabila över tid men varierar på individ- och gruppnivå som exempelvis självförverkligande, utveckla och bidra med kunskap, status, ekonomisk ersättning, socialt samspel och etiska/ moraliska drivkrafter. |
| Vård/rehab i hemmiljö | Hemsjukvård dagtid, kvällar, nätter och helger, rehab (privat och egen regi). | Målet är att erbjuda vård och rehabilitering av hög kvalitet i patientens hem, med fokus på patientsäkerhet. Vården ska syfta till att bota sjukdom, lindra symptom och förbättra patientens rörlighet och hälsa, för att hjälpa patienten att uppnå en hög livskvalitet. |
| Omsorg i hemmiljö | Hemtjänst dagtid, kvällar, nätter och helger (privat och egen regi). | Erbjuda högkvalitativ omsorg till brukare i deras hemmiljö, genom att anpassa omsorgen efter deras individuella behov och ge utrymme för dem att utnyttja sina fysiska och kognitiva förmågor. |
| Politisk- och | Regionledningskontor, service-förvaltning it, hr-stöd och upphandling, HSF, LSF, SLSO, innovationsorganisationer i Region Stockholm och Stockholms stad, centrum för hälsodata, FCBC, stadsledningskontor, stadsövergripande serviceförvaltning, stadsbyggnadskontoret, äldreförvaltning, stadsdelsförvaltningar. | Se till att offentliga medel används på ett ansvarsfullt sätt genom att skapa underlag och fatta beslut om ersättningssystem och uppföljning som möjliggör kostnadseffektiv och högkvalitativ vård och omsorg. Säkerställa att verksamheterna har nödvändiga resurser och stöd för att utföra sitt uppdrag, och att de följer lagstiftning, politiska beslut och en budget i balans. |
| Sveriges Kommuner och Regioner | | Stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners verksamhet genom bland annat samordning och fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte. |
| Socialstyrelsen | | Ta fram och utveckla statistik, regler och kunskap till olika aktörer inom vård- och omsorgssystemet. |
| Övriga vård- och omsorgsaktörer | | Akut och slutenvård, 112 akutvård/ambulans, närakut, vårdcentral i privat och egen regi, psykiatri, asih, dagverksamhet, korttidsboende, vaktmästarservice, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulent. |
| Media | | Granska, upplysa och i viss mån påverka samhällsutvecklingen. |
| Övriga organisationer som nämndes i studien | Fackförbund, polis, fastighetsägare och förvaltare, näringsliv ex. Medtech-företag, apotek. | |

Tabell 1: Aktörer, drivkrafter och målsättning med aktiviteter.

# Drivkrafter och behov

Normer och andra personers uppfattning och attityder gentemot en profession kan påverka självuppfattningen bland medarbetare inom professionen.  Om en profession anses vara högt ansedd och respekterad av samhället i stort, kan det öka känslan av status och stolthet hos de som arbetar inom den professionen. Å andra sidan, om en profession anses ha låg status eller om utövarna möter negativa attityder från andra, kan det minska deras upplevda status och arbets-tillfredsställelse.

"Sen har Rehab liksom av tradition alltid varit ointresserad av hembesök. Det är oglamoröst att gå hem till folk. Det är samma sak som att det är svårt att få folk att jobba i hemsjukvården."

Medarbetare priämrvårdsrehab

Drivkrafter, motiv och värderingar tenderar att vara stabila över tid, men kan variera på individ- och gruppnivå. Exempel på drivkrafter inkluderar status, social interaktion, kunskapsbidrag och etiska och moraliska driv-krafter hos medarbetarna. De mest sjuka patienterna vårdas hemma eftersom de inte kan ta sig till vårdcentralen. Att arbeta i patientens hemmiljö kräver trygghet, omfattande kunskap och erfarenhet, eftersom det sällan finns kollegor att rådfråga. Samtidigt visade studien på att medarbetare som arbetar i patientens hemmiljö upplever låg status i yrket. Vård i hemmiljö kan enligt respondenter bli mer attraktivt om det genererar högre ersättning än andra aktiviteter.

"Det kan ju vara så att anhöriga har väldigt mycket önskemål och det kan vara patienten själv som vill saker. Men det är inte alltid det finns möjlighet eller ens behövs."

Medarbetare hemsjukvård



Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har varje person rätt till en skälig levnadsnivå. Denna formulering är dock vag och tolkningen kan variera från fall till fall och över tid. Studien visade att förväntningarna på de vård- och omsorgstjänster som erbjuds skiljer sig åt inom den heterogena gruppen äldre. För vissa äldre handlar det om att kunna behålla en hög grad av självständighet och fortsätta att leva ett aktivt liv. För andra är det viktigare att få stöd och hjälp med de dagliga aktiviteterna, såsom personlig hygien och matlagning. Ett individ-anpassat tillvägagångssätt kan därför vara avgörande för att möta varje enskild persons behov och önskemål. En skälig levnadsnivå handlar inte nödvändigtvis enbart om de grundläggande behoven, utan också om att ha möjlighet att fortsätta leva ett meningsfullt liv med sociala interaktioner och aktiviteter som ger glädje och tillfredsställelse. Det är viktigt att säkerställa att äldre personer har tillgång till en vård och omsorg som möter deras individuella behov och önskemål, och som främjar en god livskvalitet och välbefinnande.

"Man tar ju inte hänsyn till individens dags-form när man gör ett beslut (…) Så det blir den här schablonen att förhålla sig till."

Medarbetare hemtjänst

Utförare ser en potentiell konflikt mellan individ-anpassad vård och omsorg och ett ersättnings-system som bygger på förväntade mätbara faktorer snarare än att ta hänsyn till variationen i den äldres dagliga tillstånd. Till exempel, ett toalettbesök som enligt schablon bör ta 5 minuter, kan beroende på den äldres dagsform ta upp till 20 minuter och kräva hjälp från två medarbetare. Schablonerna tar inte heller hänsyn till dagliga utmaningar och logistiska problem som exempelvis trafik-förhållanden, parkeringsmöjligheter eller om patient/brukare är utåtagerande.

Mätbara faktorer, som antalet vårdtillfällen eller tiden som spenderas med varje individ, kan vara användbara för att övervaka och utvärdera vård- och omsorgskvaliteten. De riskerar även att skapa ett incitament att fokusera på att uppnå dessa mätbara mål snarare än ett fokus på att erbjuda en individanpassad vård och omsorg. Att vara tillgänglig och flexibel kan bidra till att skapa en positiv upplevelse för brukaren/patienten och öka deras förtroende för medarbetaren.
Det är uppenbart att många medarbetare inom vård- och omsorgssektorn är engagerade och drivs av etiska och moraliska motiv.
Medarbetare utför ofta aktiviteter som inte täcks av ersättningssystemet men som är viktiga för att säkerställa en individ-anpassad vård och omsorg, hög kvalitet och en upplevelse av professionalitet.

”För det är inte så att det är gratis, så du kanske inte vill ha hjälp fast du behöver städhjälp för det blir för dyrt. (…) för det är klart att det blir dyrare än att inte ha någonting alls.”
Medarbetare hemtjänst

I den heterogena gruppen äldre varierar förmågan att antingen själva eller med hjälp från närstående överklaga biståndsbeslut till Förvaltningsrätten eller högre instans.



Foto: Amy Hirschi, Unsplash

Andra grupper av äldre saknar dock denna förmåga eller uttrycker att de inte vill belasta systemet, känner osäkerhet om sin rätt till vård och omsorg eller anser att de inte har råd att söka dessa tjänster. Detta kan leda till en ojämn fördelning av tillgängliga vård- och omsorgstjänster, där äldre som har tillgång till resurser och kunskap har större möjligheter att få tillgång till de tjänster de anser sig behöva.

Väntetiden att anpassa patienters eller brukares hem är ofta lång vilket kan bidra till ojämlik vård och omsorg. Om den äldre inte själv kan bekosta anpassningen kan det ta mellan tre månader och upp till ett år att genomföra processen med att ansöka hos regionen, kommunen och bostadsbolaget.

På sidan 32 finns idéer som kan främja självbestämmande

## Styrning och granskning

”Då tror jag mycket på att lyfta fram exempel härifrån [hemtjänsten] hur lagar och regler påverkar kvaliteten i det här mötet [med den äldre] för att kunna säga att det här är för detaljerat.” Medarbetare hemsjukvård

Hemsjukvård och hemtjänst omfattas av olika lagar och riktlinjer. Medan biståndsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätt eller högre instans, går det inte på samma sätt överklaga beslut inom hemsjukvården. Många riktlinjer som kommer från kommunfullmäktige skapas för att undvika att ärenden går vidare till domstol. Detta begränsar emellertid beslutsutrymmet och möjligheterna att skapa situations- och individanpassade lösningar. En medarbetare påpekade att det ibland finns ett behov av att backa och titta på lagens intentioner.

”Jag skulle hellre se att man kontrollerar mer kvalitetsparametrar (...) gör mer intervjuer med kunder. (...) Det vore mycket mer effektivt för det ger också en högre kvalitet för kunderna (...) då skulle det inte göra någonting om man var där 10 timmar extra den här månaden för att hon hade magsjuka.”

Medarbetare hemtjänst

I studien lyfte medarbetare ett behov av utökat utrymme att själva fatta beslut om hur tjänsterna som erbjuds ska utföras. Motiveringen är att skapa förutsättningar för att kunna möta variation i den äldres behov och dagsform. Vidare har behovet av utrymme för att arbeta mer kollegialt snarare än att verksamheterna styrs av fler



riktlinjer. Önskan är även en tydligare koppling av uppföljningsparametrar till verksamhetens kvalitetsarbete för att stödja ett mer framåtriktat arbete. Idag är uppföljningen huvudsakligen tillbakablickande och uppfattas i vissa fall som detaljstyrning.

”Tillitsbaserad styrning som det var tänkt (…) men nu kan det ju bli en förflyttning, men det blev det inte. Det är ju fortfarande väldigt mycket kontroller. Jag tycker att man tillför gärna fler kontroller man plockar inte gärna bort någon.”

Medarbetare omsorg

Uppföljning av vård och omsorg omfattar olika aspekter såsom ekonomisk uppföljning, social granskning från anhöriga och patienter/brukare, användning av NFC-taggar, uppföljning från myndigheter såsom IVO, Socialstyrelsen och SKR, samt provringningar från regionen. Det finns också omfattande massmedial granskning av hela vård- och omsorgssystemet. I studien återkom uttrycket ”rädsla för att göra fel” i intervjuer med både medarbetare och ledning. Detta riskerar att leda till att organisationerna blir mer fokuserade på att undvika negativ publicitet än på att

förbättra vård- och omsorgskvaliteten för de äldre. Under pandemiåren kände medarbetare sig särskilt hårt kritiserade och skuldbelagda för hög dödlighet bland äldre. Samtidigt anser hemtjänsten att de inte kan hållas ansvariga för beslut som fattas på en annan nivå i organisationen. Som en medarbetare uttryckte det så skall hemtjänsten inte arbeta med sjukvård och har inte heller resurser tilldelade för att göra detta.

”Det blev ju också aktualiserat under pandemin. ’Men hur kunde det bli så här’ säger media. Ja, vi måste ha mer kontroller så vi kan svara media när de undrar.” Medarbetare omsorg

En annan medarbetare lyfte att det finns en tendens att politiker blir nervösa av det massmediala trycket, vilket leder till ökad uppföljning samtidigt som resurserna som behövs för att möta uppföljningskraven skärs ned.

”Nu är det fokus på att vi inte får ha timanställda. (...) nästa månad kan vi ha en sådan himla otur att många har dött bort. Ja men fem, sex stora kunder har kanske 400-600 timmar. (...) då innebär det att vi måste ha månadsanställda i stället (…) budget i balans och hålla folk sysselsatta hänger ihop.”
Medarbetare hemtjänst

Ett politiskt beslut har fattats om att omvandla timvikariat till heltidsanställning inom hemtjänsten som en åtgärd för att skapa bättre arbetsvillkor och öka tryggheten för medarbetaren. Det ligger i linje med fack-förbundens och arbetsgivarens målsättning om att främja en god arbetsmiljö. Samtidigt är flexibla lösningar i bemanning viktiga inom såväl vård som omsorg inte minst för att möta de varierande behoven hos brukare/patienter och för att tillgodose den personalstyrka som krävs för att utföra arbetet på ett effektivt och professionellt sätt. Detta kan inkludera behovet av användning av deltid, timanställning och flexibla arbetstider, samt tillgång till extra personal vid behov. När timanställning nu förväntas minska efterfrågas kommunövergripande ”gummibandslösningar” i verksamheterna som kan öka flexibiliteten i bemanningen. I studien diskuterades även frågan om riktlinjer kring tim-anställning även gäller för privata utförare för att skapa en jämlik och rättvis konkurrenssituation.



Foto: Gabrielle Henderson, Unsplash

# Samverkan och ansvar

”En stor del av uppdraget som biståndshandläggare är att förklara systemet för patienten och anhöriga; vem som gör vad och vilka som är rätt aktörer att kontakta.”

Medarbetare omsorg

Det stora antalet vård- och omsorgsgivare som besöker den äldre i hemmet riskerar leda till svårigheter för den äldre och dennes anhöriga att veta vem de skall vända sig till i olika frågor. Då den äldre oftast endast har lappar med telefonnummer eller en pärm med kontaktuppgifter, kan det vara svårt att snabbt och effektivt få tag på rätt person vid behov. Problemet drabbar inte enbart den äldre och dennes anhöriga utan försvårar även kontakten mellan de olika utförare som ansvarar för vård och omsorg under dygnets alla timmar. För att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan de olika utförarna och den äldre är det därför viktigt att det finns tydliga riktlinjer och kommunikationskanaler kring vem som ansvarar för vad, samt att det finns strukturerade och lättillgängliga kontaktuppgift för alla inblandade parter.

Vidare kan behörighetsbegränsningar i olika system som exempelvis LifeCare leda till att med-arbetare inte får tillgång till viktig information.
Om medarbetaren vid hembesök saknar information om att brukare/patient besöker akuten eller är inlagd inom slutenvården skapar detta en onödig oro och ökad arbetsbelastning när de behöver ringa runt och söka efter information. För att underlätta arbetet och minska risken för missförstånd och felaktigheter, behöver behörighetsbegränsningarna i olika system ses över och eventuellt anpassas för att säkerställa att all relevant information är tillgänglig för de som behöver den.



”Den här organisatoriska gränsen mellan sjukvården och hemtjänsten får en riktig konsekvens, att man nu delar upp det väldigt tydligt. Förut så hade man en man en liten samverkan.”

Medarbetare i hemsjukvård

Flera medarbetare hävdade att samverkan över organisatoriska gränser snarare minskar än ökar. Hemsjukvårdens delegeringar till hemtjänsten har tagits bor som exempelvis att dela ut tabletter från ApoDos-rullar. Konsekvens för patient/brukare är att de kan få hjälp att gå till sängs för natten av hemtjänsten för att sedan väckas av hemsjukvård när de skall få sin kvällsmedicin eller byta stomipåse. Dessutom påpekar medarbetare att det underlättar om hemtjänsten, som träffar den äldre oftare än hemsjukvården, ger medicinen i de fall den äldre inte är samarbetsvillig. Hemtjänst- och hemsjukvårdsenheter är ofta små och beroende av ett fåtal medarbetare, vilket ökar sårbarheten i verksamheten när det saknas möjlighet att delegera uppgifter.

”Kontakten underlättas när man får se ansiktet bakom mailadressen vilket gör att man kan lösa små praktiska problem som annars kan leda till missförstånd.”

Medarbetare hemsjukvård

Det saknas incitament för samverkan över organisatoriska gränser i dagens ersättningssystem, vilket kan försvåra samarbete mellan olika vård- och omsorgsgivare. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller inga bestämmelser om samverkan medan behovet av ökad samverkan kring den äldre lyfts i utredningen kring ny äldreomsorgslag. Medarbetare efterfrågar ökat utrymme för tvärprofessionell samverkan och att gemensamt få möjlighet att utveckla rutiner för samverkan kring den äldre. Kontinuerliga, och gärna fysiska, möten kan underlätta samarbete och kommunikation mellan olika vård- och omsorgsgivare samt öka förståelsen och sammanhållning inom verksamheten. Genom att diskutera vardagliga problem och utbyta kunskap kan man undvika missförstånd och konflikter.

Det kan även ge medarbetare en bättre helhetsbild av vård- och omsorgssystemet och hur deras egna insatser bidrar till helheten.

”God och nära vård (…) vi flyttar vården från den specialiserade vården till primärvården och då behöver hemsjukvården kroka arm med oss [inom omsorgen].” Medarbetare Äldreförvaltningen

Läs mer om ökad samordning på sidorna 33-35



Foto: Hans-Peter Gauster, Unsplash

# Utveckling och upphandling

”Det står innovation och trådlös två hundra gånger i budgeten (…) det kommer inte ändra något bara för att det står där utan det är ju hela det här nätverket som behöver röra på sig.

Medarbetare Stadsledningskontoret

I studien framhölls behovet av att bygga upp en nätverksstruktur för att underlätta samverkan mellan olika aktörer inom välfärdsområdet. En sådan struktur skulle också ge möjlighet till att skapa nya utvecklingsarenor och arbetssätt för att kunna hantera utmaningarna som finns inom området. Samtidigt lyfter studien också fram en bristande samverkan mellan huvudmännen inom välfärdsområdet, vilket kan hindra en effektiv utveckling av välfärdsteknik och vård och omsorg för äldre. För att komma till rätta med detta behövs det samarbete och en gemensam vision mellan region- och kommunstyrelserna för att minska antalet akuta inläggningar av äldre. Genom att arbeta tillsammans och ha en gemensam strategi kan man undvika att äldre hamnar i akuta situationer och istället satsa på förebyggande åtgärder, vilket skulle kunna leda till en mer hållbar och effektiv vård och omsorg för äldre.

” Men det är liksom det som är utmaningen att de lagar och regler som finns tolkas på olika sätt (…) vi har ett stort tolkningsspann av de lagar och regler vi har som också inkluderar en väldigt restriktiv hållning” Medarbetare MedTech-företag

Vidare argumenterade flera respondenter för att dagens lagstiftning inte tar hänsyn till de möjligheter som dagens teknik ger och att utveckling och upphandling av välfärdsteknik ofta hindras av en restriktiv tolkning av lagar.



Föreställningen om att det saknas lagrum handlar i stället ofta om en rädsla att testa hur lagar skulle kunna tolkas. SKR och Socialstyrelsen lyftes fram som aktörer som skulle kunna ta fram nationella riktlinjer för att stödja tolkningen av lagar inom området för välfärdsteknik. Dessutom hävdades att det ställs olika krav på privata utförare vid upphandling i olika regioner, där vissa regioner kräver att privata utförare har samma journalsystem medan detta inte krävs i Stockholm. Detta kan leda till att patientsäkerheten riskeras då patienter har möjlighet att hämta narkotikaklassade läkemedel från olika vårdgivare. En annan utmaning som identifierades var att Socialstyrelsens statsbidrag är specifika, riktade och ettåriga. Generella statsbidrag som pågår över flera år skulle kunna stärka utveckling och innovation inom välfärdssektorn.

”Innovationsupphandling är inte skapad i sin struktur för att ha en snabb innovationscykel, utan det är långa processer.”

Medarbetare MedTech-företag

Komplexiteten i utvecklings- och upphandlings-projekt tillsammans med långa upphandlings-processer och bristande information om tidplaner för lansering försvårar implementeringen av nya tekniska lösningar.

Lokala, småskaliga utvecklings- och upphandlingsprojekt hävdades i högre utsträckning leda till en möjlighet för verksamheterna att experimentera med nya lösningar.

”Men vi sitter ju och dokumenterar det här på nytt även om det är information som är likadan. Det är ju inte så att man kan föra över den utan man måste klippa och klistra.”

Biståndshandläggare

Juridik och lagtolkning, inte minst kring sekretess, sågs som en utmaning som resulterar i merarbete och gör digitala stödsystem till lapptäcken. Det leder till att system inte synkroniseras med varandra, vilket i sin tur kräver att arbetssätt anpassas och att merarbete uppstår i form av att klippa och klistra information mellan system. Andra svårighetet som lyftes i studien är att system som biståndshandläggare arbetar i är utformade på individnivå snarare än utifrån hushåll. Detta innebär att om en partner insjuknar och matlagning är registrerad på den parten, står den andra partnern utan hjälp.

I LifeCare finns stöd för utskrivningsprocessen, men all information som olika yrkeskategorier och utförare behöver är inte tillgänglig. Det är också osäkert om informationen kommer att vara tillgänglig över regiongränser. Dessutom behövs enligt medarbetarna gemensamma rutiner för hur befintliga system ska användas och att dessa följs. För närvarande missar många enheter inom slutenvården att notera i WebCare/LifeCare när patienter blir in- eller utskrivna, vilket leder till att mycket kommunikation sker via telefon, svårigheter att nå varandra och en hel del merarbete. Fler yrkeskategorier skulle behöva ha tillgång till ett gemensamt system motsvarande LifeCare för att kommunicera patientinformation såsom medarbetade inom olika boendeformer, ambulanspersonal, koordinatorer inom hemtjänsten eller hemtjänstpersonal.

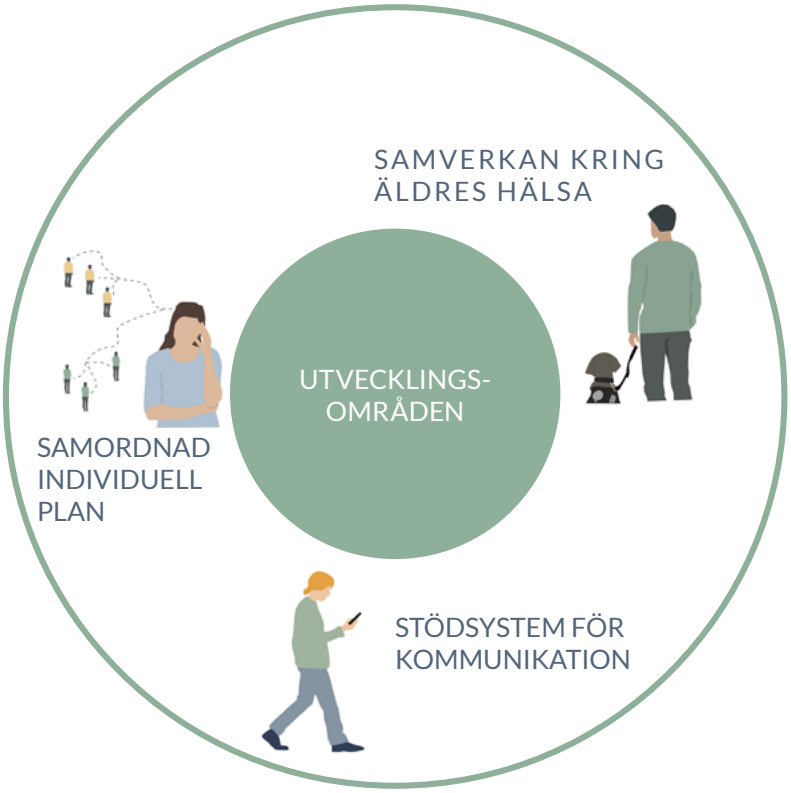
”Man startar upp med tekniken men missar sammanhanget. Det behövs mer kunskap om användarens behov och att användaren involveras i utvecklingen.” Medarbetare hemsjukvård

En annan utmaning som lyftes i studien var att det ofta finns ett teknikfokus i utvecklingsprojekt, snarare än en förståelse för kontexten och de verkliga behoven. Detta skulle kunna lösas genom samskapande eller åtminstone en användar-centrerad utveckling, där användare - det vill säga medarbetare i organisationerna - i högre utsträckning blir involverade i utvecklingen av den nya teknik som skall stödja dem i deras dagliga arbete.

”Om man ska kunna ha kvar en personal på en arbetsplats måste de tycka att det är intressant och vilja jobba här. Jag har möjligheten att göra det här. Det här med till exempel att utveckla digitala bitarna. Det är sådant som får folk och vilja stanna kvar också. Det är liksom inte bara lön.” Medarbetare rehab

Att involvera medarbetare i utvecklingen av digitala teknik för välfärdstjänster skulle även ha andra positiva effekter som att underlätta rekrytering och behålla personal. Studien visade även på att dagens ersättningssystem upplevs som hämmande för utveckling av nya arbetssätt. En medarbetare menade att om ersättningen i stället gavs för de insatser som vårdgivaren vet är bäst för patienten, så skulle det skapa bättre arbetssätt. Detta skulle också kunna öka motivationen hos vårdpersonalen att arbeta för patienternas bästa, i stället för att bara uppfylla kvantitativa mål för att uppnå ersättning.

# Slutsatser och utvecklingsområden




Figur 4. Identifierade utvecklingsområden

Hemsjukvård och omsorg står inför många utmaningar som kräver innovativa lösningar och samarbete mellan olika aktörer såsom sjukhus, vårdcentraler, kommuner och ideella organisationer. Genom detta projekt har vi skapat en plattform för samverkan med målet att bidra till en positiv utvecklingen av vård och omsorg för både patienter/brukare och medarbetare. Insikter som har uppkommit genom samarbetet har lett till identifiering av tre övergripande utvecklingsområden vilka är SIP – Samordnad Individuell Plan, Stödsystem för kommunikation och Samverkan kring äldres hälsa (se figur 4).

Varje område omfattar flera möjliga fokus-områden. Genom att bryta ner områdena i mindre delar kan man se hur olika bakomliggande problem hänger samman på olika sätt, vilket kan leda till nya idéer och lösningar. De olika områdena kan studeras separat eller tillsammans och utgöra en grund för framtida utvecklingsarbete som ytterligare skulle stärkas av samverkan mellan olika aktörer och genom samskapande aktiviteter. Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa lokala, avgränsade demo- eller labbprojekt där man testar nya lösningar på lokal nivå och sedan successivt sprider dessa till andra delar av staden eller regionen. Dessa lösningar kan även ligga till grund för framtida policyutveckling.

# Stödsystem för kommunikation

"Vi har mycket att göra på förmiddagen så det är svårt eftersom biståndsbedömare vill göra vissa besök på förmiddagen eller sjukhusen som också vill planera och skicka hem patienten efter ronden vid 10."

Medarbetare i hemsjukvården

Idag sker mycket av kontakten mellan olika vård- och omsorgsaktörer via telefon. Man ringer dem som brukar svara och hamnar ofta i telefonkö. Förmiddagarna är fulltecknade med aktiviteter, vilket gör det svårt att hinna kontakta eller svara på meddelanden. Medicin ska delas ut, brukare ska stiga upp och få frukost, och många patienter skickas hem efter ronden på förmiddagen.

Det saknas idag bra vägar för informations-överföring mellan vårdteam som inte träffas regelbundet, exempelvis mellan olika utförare som ansvarar för vård och omsorg, dagtid, kvällar, nätter och helger. Anledning för kontakt är av olika karaktär och kan handla om allt från utredning kring exempelvis demens till ett behov av påfyllning av förbrukningsartiklar hos patienten/brukaren. Alla frågor är inte lika akuta och det behövs därför olika kanaler för synkron respektive asynkron kommunikation för att undvika störningar i arbetet hos de äldre. Lösningar som nämndes i studien var bland annat chattfunktioner och forum för frågor.

Det behövs även en översyn kring hur patient/brukare och deras anhöriga hittar vård och omsorgsinformation och kommunicerar med de olika aktörerna. Olika vårdaktörer utvecklar egna appar för kommunikation med hjälp av videosamtal och chattfunktioner vilket leder till osäkerhet kring vilken app som ska användas och svårigheter för den äldre att orientera sig i de olika gränssnitten.



"Patienterna har inte våra mobiltelefon-nummer (...) det nummer som de ringer och lämnar meddelande i hamnar i vår box. (...) När vi är hos en annan patient så gillar de inte att vi svarar."

Medarbetare hemsjukvård

Patienter/brukare har inte tillgång till medarbetarnas fasta telefoner utan är hänvisade till telefonsvarare. Det kan uppfattas som att det tar lång tid att få svar på frågor som upplevs som viktiga eller till och med akuta. Samtidigt är det svårt för medarbetarna att avsätta tid till att återkoppla, eftersom de oftast är ute och besöker andra patienter/brukare. Även andra aktörer, som exempelvis polisen, behöver enkelt få tillgång till uppgifter om vem de ska kontakta. De kan ha upptäckt någon som är dement som har gått vilse. Idag är det väldigt svårt att veta vem de skall kontakta då de enbart i Farsta finns 33 hemtjänstutförare.

# Samordnad individuell plan

”Oftast planerar vi våra insatser och sjukvården planerar sina och så bjuder de in till en SIP som sker hemma, ja, när personen har landat och insatserna kommit i gång.” Biståndshandläggare

Vid utvecklingen av SIP - Samordnad Individuell Plan - behöver hänsyn tas till flera olika perspektiv. En SIP är främst den enskildes plan och syftar till att öka patientens/brukarens inflytande. Samtidigt kan SIP stödja organiseringen av den dagliga verksamheten och skulle även kunna, genom digitala lösningar, understödja samverkan genom informationsspridning och användas som ett verktyg för kommunikation över organisatoriska gränser. SIP är ett unikt tillfälle för datainsamling och även om SIP är tänkt att genomföras vid ett unikt tillfälle skulle den även kunna integreras i en kontinuerlig process från det att patienten skrivs ut från slutenvård och framåt.

Lagar och riktlinjer är centrala vid genomförandet av SIP. Primärvården är ansvarig för att sammankalla listade patienter som skrivs ut från slutenvården. Den äldre behöver dock inte ha varit inlagd på sjukhus för att erbjudas en SIP utan den ska även genomföras om hemsjukvård eller hemtjänst har upptäckt ett akut behov av insatser. Förutom patient/brukare och eventuellt anhörig ska minst två aktörer som hemsjukvård, rehab och omsorg delta. SIP ska erbjudas inom tre dagar efter hemgång och skall genomföras i hemmiljö.

Det finns en oro i verksamheterna kring hur man ska lyckas synka tider så att de involverade kan delta i en SIP. Frågor som dök upp i studien var om det följer sekretesslagstiftning eller andra lagar och riktlinjer om några aktörer deltar via videokonferens. I studien ifrågasattes även om det är rätt organisation som är sammankallande vid genomförandet av SIP och om den ska genomföras i hemmiljö. Hemsjukvårdsenheter är ofta små enheter och kan bestå av ett fåtal medarbetare



medan slutenvården har anställda koordinatorer som sköter planering kring utskrivning av patient. Det finns även en osäkerhet kring vem som har ansvaret för att följa upp överenskommelser som har gjorts under en SIP.

Andra problem som lyftes i studien kopplar till dokumentationen som sker i samband med SIP. Dels saknas digitala lösning där den äldre kan få tillgång till dokumentation vilket leder till att den måste skrivas ut i pappersform vid varje uppdatering. Det finns inte heller möjligheter att få in informationen i andra stöd-system som exempelvis Paraply som används inom hemtjänsten. Detta leder till onödigt dubbelarbete då samma information måste skrivas in flera gånger.

Medarbetare lyfte att den äldre inte alltid vet vad en SIP är och varför den genomförs. Det föreslogs att medarbetare från hemtjänsten, som är de personer den äldre har mest kontakt med, skulle kunna skapa trygghet och därmed förutsättningar för inkludering. Detta är i dagsläget inte möjligt då aktiviteten inte inkluderas i ersättningssystemet och det därmed är svårt att avsätta tid för deltagande.

Läs om SIP-bilen på sidan 34

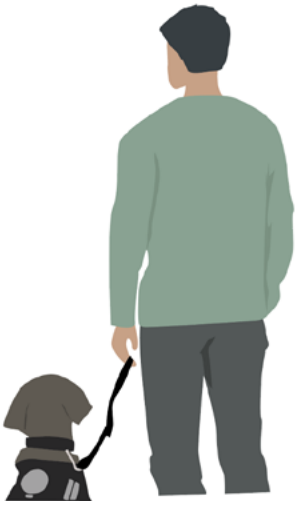
# Samverkan kring äldres hälsa

”De ekonomiska modellerna (…) ersätter inte hälsa utan sjukdom. (...) Det är olika fält och så tittar ett gäng på det sjuka och ett gäng på det friska.” Medarbetare innovarionsorganisation

De olika huvudmännen styrs av olika lagstiftning men kan mötas i en målsättning i ett gemensamt arbete kring förebyggande och hälsofrämjande åtgärder/tjänster. I studien identifierades fyra utvecklingsområden som skulle främjas av samverkan över organisatoriska gränser vilka var att stärka äldres förmåga att utföra ADL-aktiviteter (Aktiviteter i Dagliga Livet), samverkan kring utbildningsinsatser till anhöriga, gemensamma utbildningsinsatser riktade till patienter/brukare samt aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet och passivitet. Det första området som identifierades handlar om att stärka den äldres förmåga att utföra regelbundna ADL-aktiviteter, såsom att äta, sköta hygien, göra toabesök eller klä av och på sig. Målet är att den äldre ska stödjas i att bibehålla eller utveckla sin förmåga att utföra dessa aktiviteter, vilket i sin tur ökar självständighet och livskvalitet. Det är lätt för personalen att ta över dessa aktiviteter på grund av tidsbrist, i stället för att främja patientens/ brukarens förmågor. Genom samverkan kan utveckling, kunskapsspridning och samordning kring rehabiliterande åtgärder uppnås.

”Kommunaliserad rehab funktion som vardagsrehabilitering. Tänk om hemtjänsten i stället för att servera en kopp kaffe kunde (…) att vi tillsammans tar oss upp ur sängen går ut i köket, sätter på kaffe räknar måtten. Det kanske tar 30 minuter men det kanske ökar livskvaliteten och dessutom blir det ekonomiskt hållbart över tid..”

Medarbetare innovationsorganisation



Omsorgen erbjuder navigationskurser för anhöriga kring sjukdomar, möjliga insatser och juridik. Medarbetare från olika professioner inom vård och omsorg besitter värdefull kunskap som ur anhörigperspektiv bör ses som en helhet snarare än uppdelad i kunskap utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Ett intressant utvecklingsområde är att i samverkan utveckla kurser riktade till anhöriga. Åtgärden skulle kunna leda till ekonomiska vinster genom att äldre kan bo kvar längre i hemmet och olyckor undvikas. Medarbetarna får även en inblick i varandras vardag och ser sin roll i helheten.

”Det är många delar som man kanske behöver kunskap om, både om själva sjukdomen, om bemötandet, om vad det finns för insatser, hur det fungerar med juridiken”

Biståndshandläggare



Foto: Joshua Hoehne, Unsplash

”Sen finns det också olika förmågor både hos personalen och hos patienten och förmågorna beror på olika saker. Jag menar, har du en väldigt dement person så kan den säkert inte ha så många digitala vårdmöten (…) men sen kan det ju vara någon som verkligen har den här förmågan som skulle kunna klara mycket mera.”
Medarbetare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Det tredje området avser gemensamma utbildningsinsatser riktade till äldre. Gruppen äldre är en heterogen med olika bakgrund som exempelvis sociala problem, psykisk ohälsa och olika förmåga att ta till sig ny kunskap. Nya möjligheter utvecklas inom digifysisk vård och digitala vårdmöten vilket skapar ett behov bland äldre att kunna handskas med nya lösningar som introduceras i hemmet. Nya lösningar skulle även kunna leda till ökad samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst kring att stödja äldre kring egenmontering.  Utvecklingen riskerar att skapa en oro bland patienter/brukare kring integritet och vart den data som skapas tar vägen. Utbildningsinsatser skulle kunna skapa trygghet och underlätta implementering av ny teknik.

Äldre är en av de mest sårbara grupperna i samhället, eftersom de ofta har begränsad rörlighet och kanske inte har tillgång till nätverk som kan ge dem socialt stöd. Denna sårbarhet kan leda till ofrivillig ensamhet och stillasittande, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på deras fysiska och mentala hälsa. För att motverka detta kan utförare som arbetar inom vård och omsorg spela en viktig roll i att skapa förutsättningar för äldre att bli mer delaktiga i samhället.

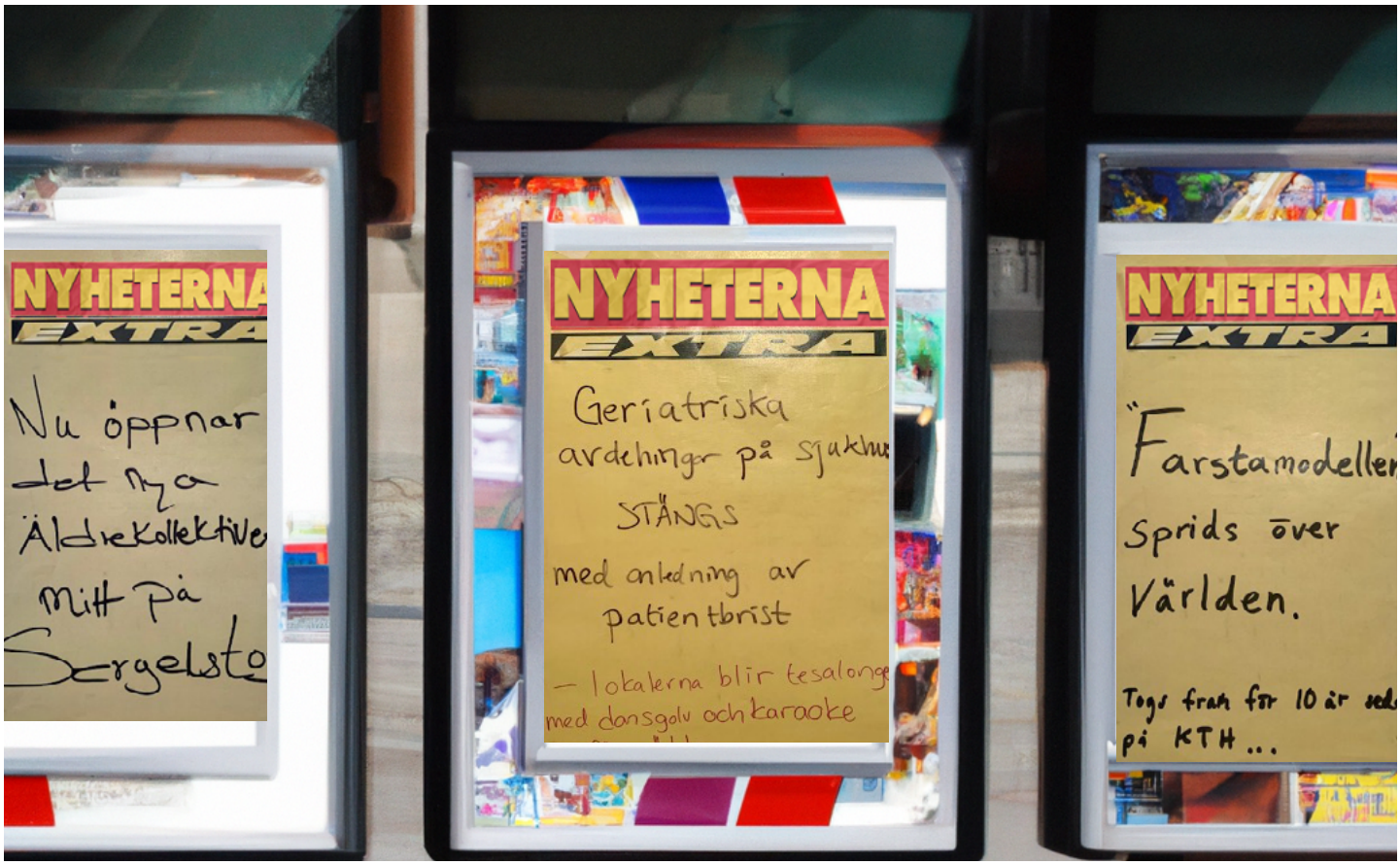
”Hemtjänsten kan ju upptäcka att ja, men Kalle som vi levererar mat till i en gång i veckan det verkar vara lite skralt med hans sociala kontakter. Då försöker de att just att länka honom till öppen verksamhet..”
Medarbetare omsorg

Ökad samverkan mellan de olika huvudmännen för vård och omsorg skulle kunna leda till att äldre i högre utsträckning får tillgång till information om aktiviteter och organisationer som kan hjälpa dem att komma igång. Utförare kan också hjälpa äldre att ta steget att delta i aktiviteter genom att ge praktiskt stöd och motivation. Genom att även samverka med externa aktörer, som exempelvis Riksidrottsförbundet, skulle de olika parterna kunna dra nytta av varandras resurser och kompetens för att utveckla och testa tjänster som bättre möter målgruppens behov, förutsättningar och förmågor.

Läs om samverkan kring äldres hälsa på sidan 35

# Framtidsvision

I slutet av projektet anordnades en workshop där vi gick från nulägesbeskrivning till framtidsvision. Deltagarna arbetar inom hemsjukvård, hemtjänst, rehab, biståndshandläggare och strateger från verksamheterna. Under workshopen genomfördes ett antal kreativa övningar där deltagarna fick utveckla idéer kring en visionsdriven och samordnad vård och omsorg av sköra äldre i deras hemmiljö. Övningarna var utforskande och hade som målsättning att identifiera ett önskat läge och vad som står i vägen respektive möjliggör en förflyttning mot den situation som skulle vara att föredra.




Figur 5. Löpsedlar skapade i samband med avslutande workshop

## Positiv och negativ brainstorming

### Försämrade förutsättningar

Patient/brukare

- Servera brunch för att spara in på frukost och lunchbesök.
- Bad- och duschdag för alla på badhus.
- Neka alla sjukresor och färdtjänst.
- Längre väntetid till sjukvården.
- Städ varje 6 månad, gör korsdrag varje vecka.
- Ingen samverkan mellan aktörer.
- Ingen fysisk vård.
- Byt personal varje dag eller oftare.
- Insatser kortas för den enskilde.

Verksamhet

- Servera brunch för att spara in på frukost och lunchbesök.
- Ät mat tillsammans med kund och spar tid.
- Byt chefer oftare.
- Anställ färre personer.
- Dubbelpass.
- Spara in på cyklar/inga cyklar, bilar/ inga bilar.
- Fler och bättre anpassade färdmedel.
- Sluta utbilda.
- Ingen samverkan mellan inblandade.

Figur 6. Försämrade förutsättningar för patient/brukare respektive verksamhet.

I samband med workshopen genomförde deltagarna en brainstorming för att diskutera vilka förutsättningar som skulle kunna försämra eller förbättra deras dagliga arbete samt den vård och omsorg som erbjuds till patienter/ brukare. Vid den ”negativa” brainstormingen (se figur 6) lyftes frågor om bland annat kontinuitet, arbetsvillkor, utbildning och insatser.

Vid den ”positiva” brainstormingsövning (se figur 7) lyftes inte oväntat en ökad samverkan. Deltagarna menade bland annat att fysiska träffar och möjligheten att delta i gemensamma utbildningar över organisatoriska gränser skulle skapa flera fördelar. Förutom att möjliggöra lärande och erfarenhetsutbyte och skapa bättre förutsättningar för samordning över organisatoriska gränser argumenterade man för att det skulle underlätta att lösa vardagliga problem och missförstånd samt minska fördomar mellan professioner. Deltagare lyfte även att det skulle leda till en ökad förståelse för den egna rollen i vård- och omsorgssystemet vilket, enligt deltagare, samskapandet i detta projekt visat på. Från ett verksamhetsperspektiv lyftes även resursfrågor och behovet av att kunna synkronisera stödsystem. Det ansågs vara av vikt att ha tillgång till och utveckla verktyg för kommunikation och informationsspridning, både ur medarbetar- och gruppen äldres perspektiv. Slutligen diskuterades även längre och mer omfattande insatser för äldre och aktiviteter som bryter social isolering och passivitet.

Deltagarna identifierade dessutom faktorer som kan främja respektive hindra utveckling inom vård och omsorgssystemet (se figur 8).

## Förbättrade förutsättningar

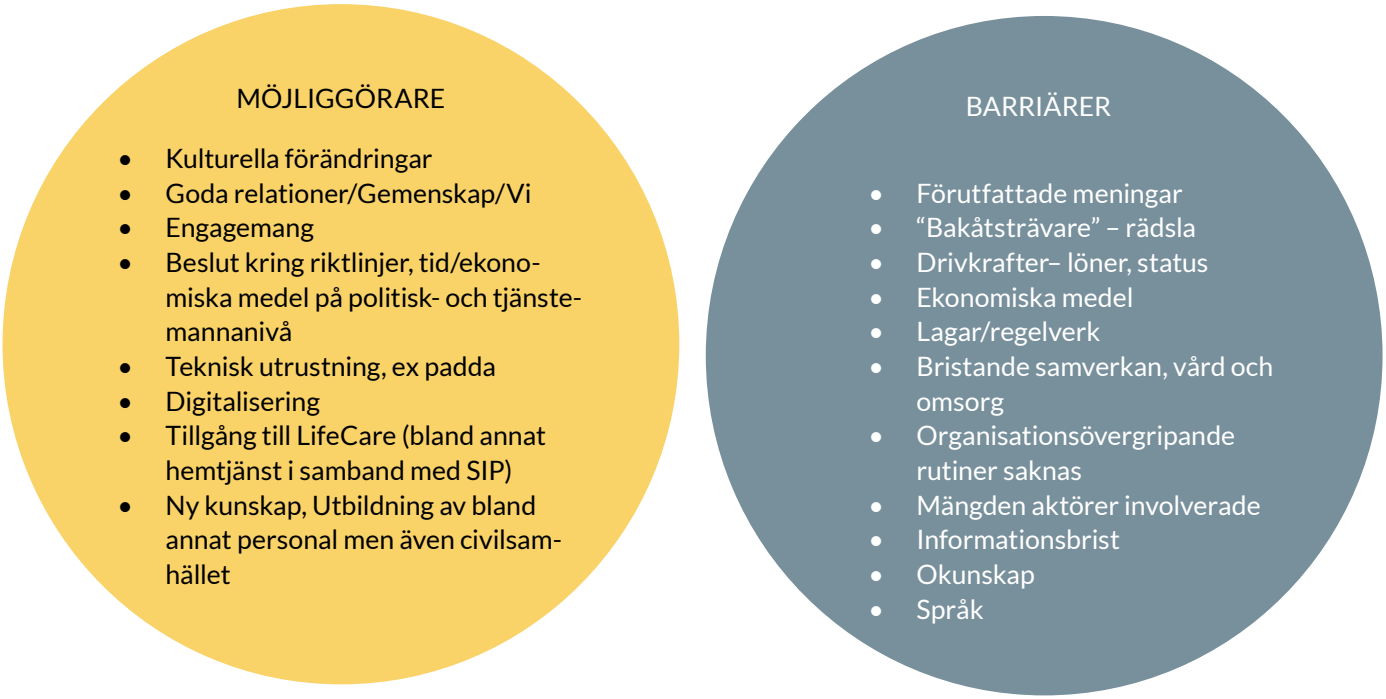
### Patient/brukare

- Lättare få äldreboende när man själv vill för att slippa vara ensam och träffa folk.
- Tvätt och städ vid behov.
- Daglig dusch, hårtvätt och utevistelse.
- Alla får besöka i hemmet av samma läkare en gång per vecka alt. månad.
- Samma personal varje dag och pass.
- Näringsrik, ekologisk, hemlagad önskekost.
- Storkök och bakning med kund.
- Dejtingstöd
- Bidrag till kulturliv.
- Hembesök av frisör och SPA-terapeut.
- Bidrag till organiserade resor och utflykter såsom dansbandskryssningar.
- Möjliggör social samvaro i grupp för äldre.
- Träfflokal där man kan fika och äta mat tillsammans gamla och unga.
- Aktiviteter som biståndsbedömd insats exempelvis träning med gummiband.
- Mer tid att uppmuntra äldre att vara så självständig som möjligt, tid att ”göra själv”.
- Mobiler till alla kunder.
- Ipad till alla, online-samtal med anhöriga som bor långt bort.

### Verksamhet

- Mer resurser, mer personal och bra villkor för all vård och omsorgspersonal så de stannar kvar.
- Retreat/utbildning mellan biståndsenhet, rehab, hemsjukvård, hemtjänst.
- Ökad samverkan mellan alla inblandade aktörer.
- Ge alla verksamheter betalt för de SIP:ar som behövs och genomförs.
- Möjlighet att delge varandra information.
- Anpassa/synka journalsystem och LifeCare.
- Släpp in hemtjänsten i LifeCare.
- Alla har en egen anpassad telefon med rätt kontaktuppgifter – knapp” för SIP.
- Släpp in hemtjänsten i LifeCare.
- Anpassade bostäder, hiss osv.
- SIP-patrull med biståndshandläggare, hemsjukvård, rehab, hemtjänst som åker runt tillsammans.

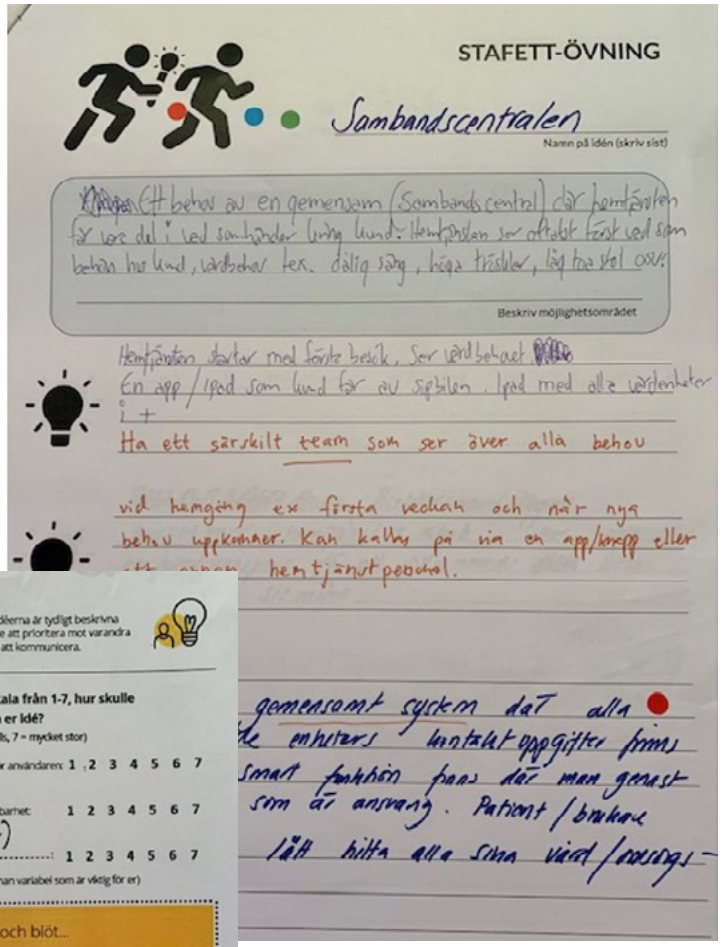
Figur 7. Förbättrade förutsättningar för patient/brukare respektive verksamhet.

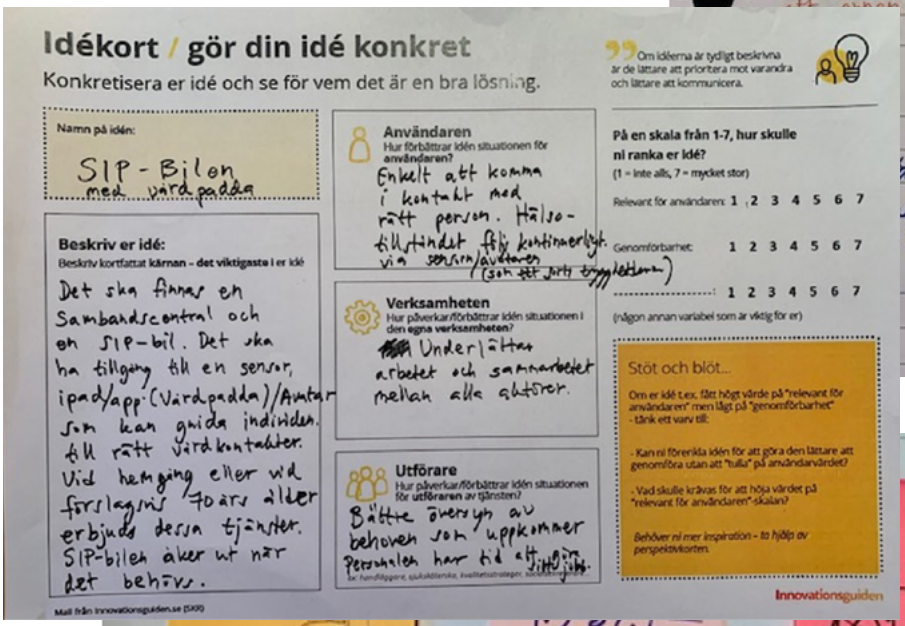


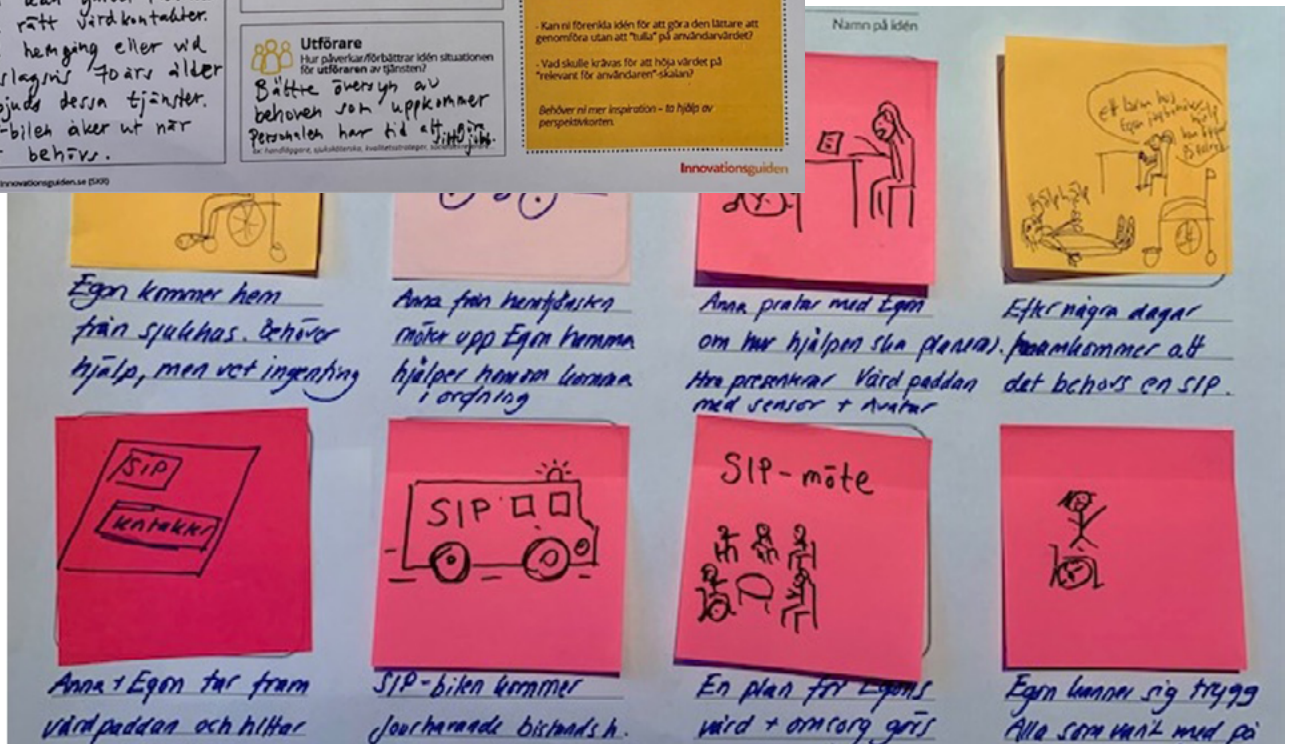

Figur 8. Främjande och hindrande faktorer för utveckling inom vård- och omsorgssystemet.

# Förbättrade och nya tjänsteerbjudanden

Under workshopen utvecklade deltagarna ett antal koncept vilka presenteras i kommande sidor. Det är viktigt att notera att det finns en distinktion mellan att utveckla koncept och att ta fram konkreta lösningar. Utveckling av koncept handlar om att generera idéer och utforska olika möjligheter. Målsättningen är att identifiera områden som behöver förbättras, vilket kan leda till att man börjar fundera på olika sätt att lösa ett problem. De koncept/ idéer som skapade kan grupperas i fyra områden. Individanpassning och inflytande, Samverkan och kommunikation, Samordnad individuell plan, Samverkan kring äldres hälsa.




I samband med den avslutande workshopen genomfördes ett antal kreativa övningar som stafettövning och scenarioskapande.

# Individanpassning och inflytande



INDIVIDANPASSAD VÅRD OCH OMSORG

- Noga lyssna och dokumentera vad som är viktigt och intresserar den äldre och aktivt arbeta i personalgrupper med informationen.
- Att det finns tid och utrymme för självbestämmande. En person som saknar anhöriga får hjälp att reda ut vad den vill.
- Längre tid för besök av hemtjänst, rehab och hemsjukvård där personalen kan vara mer spontana med vad som skall göras snarare än minutstyrda insatser.
- Att veta vem som ska kontaktas i stället för som idag ha kontakt med flera instanser/personer.
- Att det ges möjlighet till bostad utan trappor utan att flytten innebär negativa konsekvenser som exempelvis ekonomiskt.
- En alternativ bostadsförmedlingen som även underlättar flytten vilket skulle kunna leda till en omfördelning av lägenheter i samhället.

TEKNISKA HJÄLPMEDEL SOM STÖD FÖR SJÄLVBESTÄMMANDE/INFLYTANDE

- Förenkla teknik som exempelvis undvik knappvalstelefoner.
- Att den äldre får möjlighet att välja om insatsen ska utföras via en person eller med teknik som exempelvis duschrobot.
- Ipads med bilder vid handling av mat.
- Surfplatta som ger förslag på aktiviteter som passar den enskilde.
- En stor röd knapp som den äldre kan trycka på om hen känner sig kränkta eller överkörda. Krav på att någon kontaktar den äldre inom 2 timmar och tar reda på vad som hänt.

# Samverkan och kommunikation



SAMBANDSCENTRALEN

- Det finns ett behov av en gemensam sambandscentral där hemtjänsten får vara del i vad som händer kring patienten. Hemtjänsten ser oftast först vad som behövs hos kund, nya vårdbehov eller exempelvis dålig säng, höga trösklar, låg toastol, osv.
- Hemtjänsten startar med ett första besök och ser vårdbehovet.
- Ett särskilt team som ser över behov vid hemgång exempelvis första veckan och när nya behov uppkommer.
- Ett gemensamt system där alla samverkande enheters kontaktuppgifter finns samlade. Smart funktion ”SIP-knapp” där man genast hittar vem som är ansvarig. Även patient/brukare ska lätt hitta alla sina vård- och omsorgskontakter.

ÖKAD SAMORDNING

- Regelbundna möten mellan alla instanser för att stämma av behov, resurser, tankar.
- Hjälpa till och underlätta i varandras arbetsuppgifter.
- Uppdaterade verktyg för kommunikation.
- Anpassa/synka journalsystem och LifeCare.
- Släpp in hemtjänsten i LifeCare
- All personal har en egen anpassad telefon med rätt kontaktuppgifter.

# Samordnad individuell plan



SIP-BILEN

- Fånga upp personer i behov av SIP.
- Ha ett team av utbildad personal som åker runt och informerar individer över 70-år eller vid behov.
- Biståndshandläggare, hemsjukvård, hemtjänst plus rehab har alla en beredskapsjour för att tillsammans kunna åka ut på SIP-möten.
- En digital fixare, SIP-bilen (sambandscentral) som delar ut en iPad med all info som telefonnummer, digital kontakt, mätare (klocka) som mäter hälsotillståndet, knapp att trycka på för att få kontakt och möjlighet att prata med kunden via iPaden.
- Hälsodata som är kopplad till iPaden – läser av hälsan och kallar till SIP.

SIP

- Alla enheter får ersättning när en SIP genomförs för att på så vis kunna ha personal redo när det behövs.
- En särsklid dag eller en viss tid öronmärkt för samverkan och hembesök/genomförande av SIP. Finns det inga behov den specifika dagen inriktas det på samverkansmöten för att lära känna varandra och planera vidare. Tiden kan även avsättas för att göra “reklam” via hembesök/öppet hus för information om hur en SIP fungerar.

# Samverkan kring äldres hälsa



AKTIVITETSMOTIVERING
I HEMMET

- Möjlighet att delta i aktiviteter, som sker utanför hemmet, digitalt via en padda med hjul. Då kan man åka omkring i lokalen (styrs via app) och delta i de olika aktiviteterna.
- Lite enkla sällskapsspel i ”ryggan” vid besök hos den äldre. Kan vara frågespel – Fia med knuff, schack, 4 i rad.
- Storkok och bakning tillsammans med brukaren.
- Tillgång och stöd att ha husdjur som exempelvis samverkan med katthem.
- Aktiviteter som biståndsbedömd insats till exempel träning med gummiband.

ATT BRYTA OFRIVILLIG
ENSAMHET OCH PASSIVITET

- Föreningskultur med olika verksamheter – utbildning – kultur – rörelse såsom promenad- och simningsgrupper
- Hemskick med föreslagna aktiviteter - som lockar till aktiviteter - som de föranmäler sig till och får hjälp att ta sig till och från.
- Träfflokal där man kan fika och äta mat tillsammans över generationsgränser.
- Dejtingcafé/Dejtingstöd
- Resor såsom dansbandskryssningar, organiserade utflykter/resor inrikes och utrikes. Bidrag och stöd till resor.
- Spa-dagar
- Kontaktperson som kan följa med på teater, åka och shoppa, fika, och opera.

# Nästa steg



Utifrån de insikter som skapats i studien föreslås samverkan och samskapande mellan vård- och omsorgsaktörer kring i huvudsak tre utvecklingsområden, vilka är stödsystem för kommunikation, SIP - Samordnad Individuell Plan och samverkan kring äldres hälsa.

Det finns ett behov av att skapa gemensamma stödsystem för kommunikation och informationsspridning. Dessa stödsystem bör utformas så att de stödjer såväl synkron som asynkron kommunikation för att möjliggöra för de olika vård och omsorgsaktörerna att samarbeta och dela information på ett effektivt sätt, utan att begränsas av organisatoriska gränser.

Det är viktigt att samverka i utvecklingen av att hitta nya arbetssätt, organisatoriska eller digitala lösningar som stärker organisationernas förutsättningar att praktiska genomföra en SIP. För att adressera denna fråga kommer forskare från KTH och Stockholms universitet att inom kort skicka in en ansökan om forskningsfinansiering för att samarbeta med Region Stockholm och Stockholms stad i syfte att fortsätta utforska detta område. Genom att arbeta tillsammans kan dessa aktörer bidra till att utveckla innovativa lösningar för att förbättra SIP och göra det till ett mer användbart verktyg för vård- och omsorgsaktörer.

Slutligen ser vi en stor potential i ökad samverkan kring äldres hälsa. En studie från Socialstyrelsen (2022) visar att 42% av hemmaboende äldre med hemtjänst upplever ofrivillig ensamhet. Kvinnor upplever ensamhet i större utsträckning än män (Socialstyrelsen, 2022) och upplevd ensamhet och socioekonomiska förhållanden har också visat sig ha en koppling (Pikhartova et al., 2016). Gardiner et al (2018) lyfter fram behovet av ökad samverkan för att minska ofrivillig ensamhet.

Det saknas också vetenskapliga studier om hur interventioner kan minska ensamhet bland äldre personer i nordiska länder (Dahlberg et al, 2020; Socialstyrelsen 2020; Gardiner et al, 2018). Forskning visar även på sambandet mellan ensamhet och minskad fysisk aktivitet och sämre fysisk och kognitiv hälsa (Ong et al., 2016). Kopplingar har till exempel identifierats mellan ensamhet och försämrad minnesfunktion (Ayalon et al., 2016).

Forskare från som varit involverade i detta projekt har nyligen ansökt om forskningsfinansiering. Syftet med ansökan är att tillsammans med aktörer från vård, omsorg och föreningslivet skapa ny kunskap om hur målgruppens varierande behov, förutsättningar och förmågor kan mötas. Utöver de organisationer som har deltagit i detta projekt, kommer Riksidrottsförbundet och nya professioner såsom äldre kuratorer också att delta. Avsikten är samskapa och testa nya värdeskapande tjänster som kan bidra till att minska ofrivillig ensamhet och passivitet bland äldre personer.

# Slutord

Studien visar på en stor variation i perspektiv inom vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre som får vård och omsorg i sina hem. Normer och attityder till professionen påverkar upplevd status och arbetstillfredsställelse bland medarbetare. Att arbeta i patientens och brukarens hemmiljö har låg status, trots att det kräver erfarenhet och självförtroende eftersom det sällan finns kollegor i närheten. En tydlig drivkraft bland medarbetare är att vara tillgängliga, flexibla och att arbeta förebyggande vilket kopplas till professionalitet och kvalitet. Vidare påverkas medarbetarens strävan mot att erbjuda en jämlik vård och omsorg av faktorer som utbud och den äldres bakgrund och förutsättningar.

Mycket av den uppföljning som utförare förväntas rapportera upplevs som detaljstyrning snarare än som ett verktyg för kvalitetsförbättring. Vård och omsorg utsätts dessutom för hård granskning, inte minst via media, vilket skapar rädsla för att göra fel och leder ofta till ökad mängd kontroller och uppföljning. I organisationerna upplever man att upphandlings- och utvecklingsprocesser tar för lång tid vilket resulterar i system som inte är anpassade efter nya lagar, och inte synkar med varandra vilket leder till dubbelarbete. Dessutom anser man att befintliga ersättningssystem hindrar utveckling av välfärdsteknik och nya arbetssätt. Utveckling och upphandling av välfärdsteknik hindras även av en restriktiv tolkning av lagar och det finns en önskan om nationella riktlinjer kring hur olika lagar bör tolkas. Trots intentionen att öka interorganisatorisk samverkan upplevs den i dagsläget snarare minska. Ersättningssystemen skapar inte incitament för samverkan över organisatoriska gränser. Medarbetare efterfrågar utökat utrymme för kollegial och tvärprofessionell samverkan samt fler fysiska möten över organisatoriska gränser.



Medarbetare inom hemsjukvård, rehab och hemtjänst har varit centrala aktörer i projektets samskapande aktiviteter. Foto: jeshoots, Unsplash

Samskapande har varit centralt i projektet, och medarbetare från deltagande organisationer har haft en framträdande roll i de aktiviteter som genomförts. Jag vill passa på att tacka forskarkollegor och designkonsulter som varit involverade i projektet men framförallt vill jag vända mig till alla chefer och medarbetare som deltagit i projektet. TACK till Farsta stadsdelsförvaltning, hemsjukvården på Gubbängens vårdcentral, Capio rehab Farsta, äldreförvaltningen och innovationsorganisationen i både Stockholms stad och Region Stockholm. Ett stort tack för alla givande diskussioner, energi och engagemang som ni har bidragit med under projektets gång, era perspektiv och erfarenheter har varit avgörande! Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta framöver för att driva förändring och utveckling inom vård- och omsorgssektorn.

Förhoppningen är att resultaten från vårt gemensamma utforskande skall stödja framtida policyutveckling, utveckling av nya värdeskapande arbetssätt, organisatoriska- och digitala lösningar och därmed främja en socialt- och ekonomiskt hållbar utveckling av vård- och omsorgssystemet.

# Referenser


Ayalon, L., Shiovitz-Ezra, S., & Roziner, I. (2016). A cross-lagged model of the reciprocal associations of loneliness and memory functioning. Psychology and Aging, 31(3), pp 255–261.

Costa, J., Diehl, J. C., & Snelders, D. (2019). A framework for a systems design approach to complex societal problems. Design Science, 5.

Dahlberg L, Frank A, Lennartsson C, McKee K, Naseer M, Rehnberg J. (2020) Ensamhet bland äldre personer i Norden. TemaNord 2020:517 på uppdrag av Nordisk Ministerråd; 2020.

Engeström, Y. (1999) Perspectives on AT, Engeström, Y., Miettinen, R., Punamäki, R-L. (Ed.) Cambridge University Press

Gardiner C, Geldenhuys G, Gott M.(2018) Interventions to reduce social isolation and loneliness among older people: an integrative review. Health & social care in the community. 2018;26(2) pp. 147-57.

Irwin, T. (2015). Transition design: A proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research, Design and Culture. Design and Culture, 7(2), 229–246.

Jones, P. H. (2014). Systemic Design Principles for Complex Social Systems. In G. S. Metcalf (Ed.), Social Systems and Design (Vol. 1, pp. 91–128). Springer Japan.

Ong AD, Uchino BN, Wethington E. (2016) Loneliness and Health in Older Adults: A Mini-Review and Synthesis. Gerontology 62(4), pp 443-449.

Pikhartova, J., Bowling, A., & Victor, C. (2016). Is loneliness in later life a self-fulfilling prophecy? Aging & Mental Health, 20(5), 543–549.

Rylander, L. and Eneberg, M. (2022) Designing for change in complex socio-technical systems, Ed. Goldschmidt, G. and Tarazi, E., The 13th DTRS conference, Expanding the frontiers of design, Haifa, Israel., pp 478-491

Socialstyrelsen (2022) Öppna jämförelser 2022. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen Retrieved 2023-01-11

Socialstyrelsen (2020) Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-12-8239.pdf , Retrieved 2023-01-11

SOU 2022:41. Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, Stockholm



Läs rapporten digitalt